Déterminants de santé

Enseignement du 20 octobre 2026 · Université Paris-Saclay

Comprendre la santé suppose de relier les caractéristiques d'une personne à son entourage, à ses conditions de vie et aux choix collectifs. Cette fiche organise les notions autour de trois questions : qu'est-ce qui influence la santé, comment se forment les inégalités et sur quels leviers peut-on agir ?

Définitions et risques · p. 1
Modèle en cinq couches · p. 4
Inégalités de santé · p. 6
Accès et littératie · p. 8
Interventions · p. 11
Raisonnement infirmier · p. 14
Synthèse générale · p. 16
Lexique · p. 17

01 Comprendre les déterminants de santé

Un **déterminant de santé** est un facteur personnel, social, économique ou environnemental qui influence l'état de santé d'une personne ou d'une population. Il peut favoriser la santé ou la dégrader. L'analyse ne se limite donc ni à une maladie, ni aux seuls comportements individuels : elle examine aussi les conditions dans lesquelles les personnes vivent, apprennent, travaillent et accèdent aux soins.

Un **facteur de risque** renvoie à une probabilité plus élevée de survenue d'un problème de santé en présence d'une exposition. Les deux notions ne s'excluent pas : le tabagisme est un facteur de risque, tandis que le revenu, le contexte de travail, l'entourage ou les pratiques commerciales peuvent contribuer à expliquer cette exposition. Chercher les déterminants revient à remonter en amont du problème observé.

Question posée	Ce que l'on cherche
Quel problème de santé observe-t-on ?	L'état de santé, la maladie, ses conséquences et les besoins de la personne.
À quelles expositions la personne est-elle confrontée ?	Les risques et les ressources : tabac, alimentation, activité physique, sommeil, soutien, conditions matérielles…
Pourquoi ces expositions et ces possibilités d'action ?	Les conditions sociales, économiques, institutionnelles et environnementales qui rendent certains choix plus faciles ou plus difficiles.

Une conséquence pratique importante

Une personne qui ne suit pas un traitement ou ne change pas son alimentation n'est pas nécessairement indifférente à sa santé. Le coût, les horaires, l'instabilité du logement, la compréhension du traitement ou la charge familiale peuvent limiter sa capacité d'agir. Comprendre ces obstacles permet de construire une aide réaliste.

Du constat des différences aux modèles explicatifs

Les exemples historiques de Graunt et Petty, puis les travaux de Villermé au XIXe siècle, montrent que la mortalité varie selon les lieux et les conditions sociales. Le rapport de Lalonde, en 1974, distingue plusieurs champs : biologie humaine, environnement, habitudes de vie et organisation des soins. Le modèle de Dahlgren et Whitehead met ensuite plus nettement en évidence l'imbrication des niveaux d'influence.

Priorité de compréhension

Savoir définir un déterminant, distinguer déterminant et facteur de risque, puis expliquer pourquoi une analyse centrée uniquement sur le comportement individuel est insuffisante.

02 Les grands risques : comprendre leurs interactions

Le panorama introductif rappelle le poids des cancers et des maladies cardiovasculaires parmi les grandes causes de décès en France, ainsi que celui des maladies respiratoires et des causes externes. Son rôle est de montrer l'intérêt de la prévention et des déterminants, non de réduire toute la santé à une liste de maladies.

Exposition ou situation	Conséquences et raisonnement à retenir
Tabac	L'exposition contribue à des cancers, des maladies cardiovasculaires et des atteintes respiratoires. Le cours le présente comme un enjeu majeur de mortalité évitable. La question suivante est sociale : qui est le plus exposé et dans quelles conditions ?
Alcool	Les risques ne concernent pas seulement les cancers : ils touchent aussi le système cardiovasculaire, le foie, le système nerveux et le métabolisme, et participent aux accidents et aux chutes.
Association tabac–alcool	Le cours souligne que plusieurs expositions peuvent se combiner et renforcer leurs effets. Il ne faut pas transformer cette idée en addition automatique de coefficients de risque.
Maladies cardiovasculaires	L'AVC, l'infarctus du myocarde et l'embolie pulmonaire illustrent l'importance de la morbidité, de la mortalité et des séquelles. Les vulnérabilités et les conditions de prise en charge comptent aussi.

Le message relatif à l'alcool est de distinguer **repères de réduction des risques** et absence de risque. Dans les documents du cours, limiter la consommation ne transforme pas l'alcool en facteur protecteur vis-à-vis des cancers. Une même exposition peut avoir plusieurs conséquences : il est réducteur de ne retenir que le risque de cancer ou que le risque d'accident.

Prévenir sans se limiter au conseil individuel

Le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, le tabac ou l'alcool peuvent être discutés avec une personne. Mais une recommandation isolée n'explique pas comment elle pourra concrètement modifier ses habitudes. Une action pertinente s'intéresse aussi au logement, à l'emploi, au soutien disponible, à l'offre de proximité et aux ressources financières.

Lire une donnée de santé

Toujours distinguer incidence, prévalence et mortalité, puis préciser la population et l'année. Un nombre observé dans une enquête n'est ni une probabilité individuelle certaine, ni une valeur valable pour toutes les populations.

03 Alimentation, activité et gradient des expositions

La nutrition met en relation les apports alimentaires et les dépenses de l'organisme : fonctionnement basal et activité physique. Le cours relie une nutrition inadaptée aux maladies cardiovasculaires, au diabète de type 2, à l'hypercholestérolémie et à certains cancers. Il évoque aussi l'ostéoporose. Les conséquences ne se limitent donc pas au poids.

La **sédentarité** concerne le temps passé dans des activités peu dépensières, notamment assis ou allongé hors sommeil ; elle ne se résume pas à l'absence d'une séance de sport. L'alimentation, les déplacements, les rythmes de travail et le sommeil doivent être replacés dans leur contexte quotidien.

Repère présenté dans le cours	Interprétation correcte
Obépi 2020 : 47,3 % d'adultes en excès de poids, dont 17 % en situation d'obésité	L'obésité fait partie de l'excès de poids : on ne doit pas additionner ces deux proportions. Il s'agit de repères datés de l'enquête citée.
Tabac : exposition plus élevée quand le diplôme ou le niveau de vie diminuent	Les graphiques illustrent un gradient social. Le chômage apparaît également associé à une exposition plus importante.
Alcool : certains indicateurs de consommation sont plus élevés chez les personnes diplômées ou aisées	Le sens du gradient peut varier selon l'exposition et l'indicateur. On ne peut pas transposer mécaniquement le gradient du tabac à toutes les consommations.
Excès de poids et obésité : proportions plus élevées dans certaines catégories moins favorisées	Le cours compare notamment ouvriers, employés, professions intermédiaires et cadres. Les possibilités d'accès à une alimentation adaptée ne sont pas identiques.

Les conduites à risque présentées sont diverses : consommation de substances, certaines addictions comportementales, expositions sexuelles non protégées, comportements dangereux dans les transports, certaines pratiques sportives ou violences. Cette liste sert à élargir le raisonnement ; elle ne permet pas de qualifier une personne à partir de sa catégorie sociale.

Exemple : un conseil qui rencontre une contrainte

Conseiller des repas variés à une personne sans équipement pour cuisiner, avec un budget très limité et des horaires décalés ne suffit pas. Le raisonnement consiste à identifier la contrainte, puis à rechercher une solution accessible avec la personne et les ressources locales.

À retenir

Les expositions ont une dimension individuelle, mais leur répartition et les possibilités de les modifier sont aussi socialement déterminées.

04 Dahlgren–Whitehead : cinq couches imbriquées

Le modèle de **Dahlgren et Whitehead (1991)** organise les déterminants en cinq niveaux. Les couches extérieures ne sont pas un décor autour d'une personne autonome : elles contribuent à façonner ses ressources, ses expositions et ses marges de choix. Les niveaux sont reliés ; ils ne constituent pas cinq causes isolées que l'on pourrait additionner.

Lire le modèle de l'extérieur vers le centre

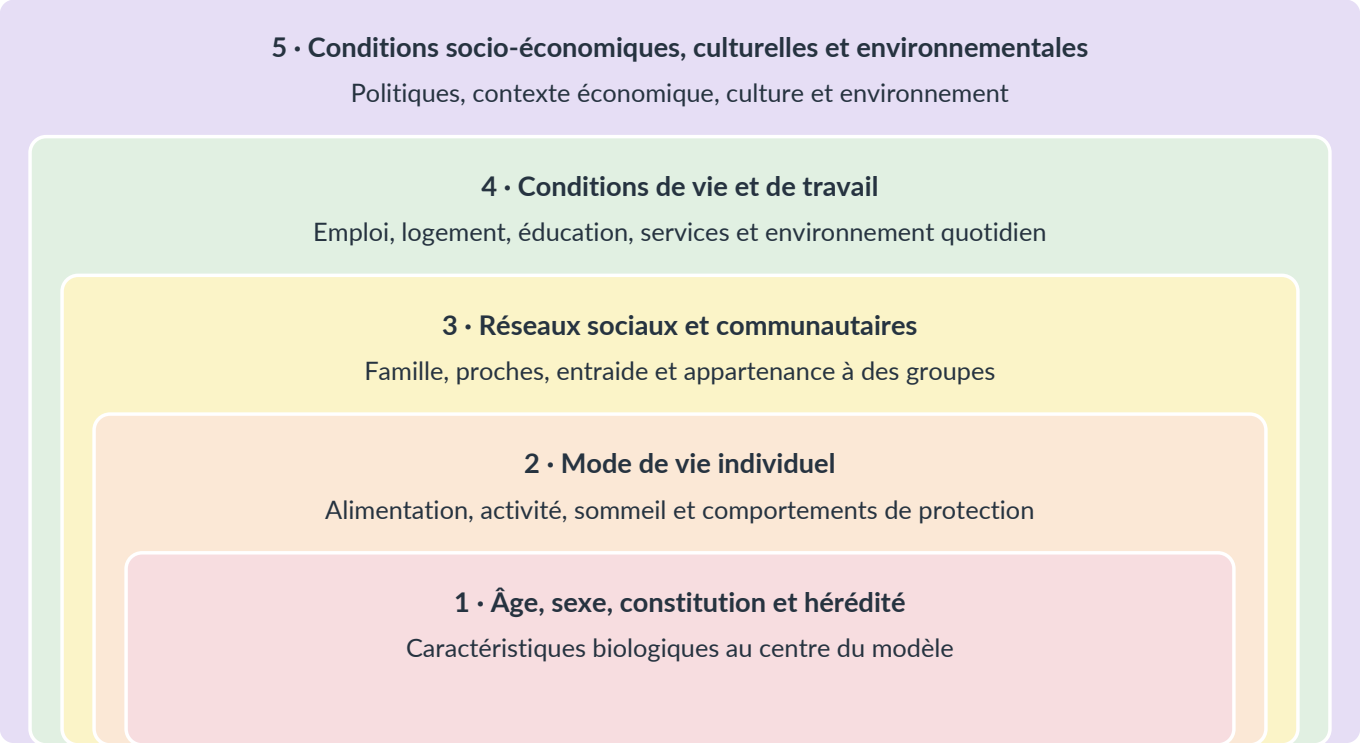


Schéma simplifié en couches : les conditions collectives influencent les possibilités d'action à l'échelle individuelle. Les couleurs reprennent les familles du modèle présenté en cours.

Niveau	Exemples et distinction à maîtriser
Centre : caractéristiques individuelles	Âge, sexe biologique, constitution et hérédité. Une intervention préventive ne modifie pas directement ces caractéristiques de la même façon qu'une habitude de vie.
Mode de vie individuel	Tabac, alcool, alimentation, sommeil, activité physique, comportements de protection. Modifiable ne signifie pas libre de toute contrainte.
Réseaux sociaux et communautaires	Soutien familial ou amical, voisinage, associations, réseaux d'entraide. Le capital social peut faciliter l'action ou, selon le contexte, entretenir certaines expositions.
Conditions de vie et de travail	Accès à l'emploi, qualité du travail, logement, formation, services de santé et services sociaux, eau, alimentation et espaces accessibles.
Conditions générales	Politiques sociales et économiques, protection sociale, contexte économique, discriminations et expositions environnementales à grande échelle.

Ne pas confondre classification et explication

Classer une exposition dans une couche est un point de départ. Il faut ensuite expliquer ses liens avec les autres niveaux : des horaires difficiles peuvent modifier le sommeil, réduire l'activité physique et rendre les rendez-vous moins accessibles.

05 Du contexte quotidien aux déterminants structuraux

Le **capital social** désigne ici les ressources relationnelles sur lesquelles une personne peut s'appuyer : famille, amis, voisins, groupes et réseaux d'entraide. Un soutien peut aider à comprendre une information, à se déplacer, à maintenir un changement ou à faire face à une difficulté. L'isolement prive au contraire de certaines de ces ressources, sans que l'on puisse résumer toute la situation d'une personne à la seule présence d'un entourage.

Un éclairage complémentaire

L'intervenant évoque l'autonomie, le sentiment de compétence et l'appartenance sociale, issus de la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan. Cet exemple aide à comprendre la place du soutien : se sentir capable, acteur et inclus. Il est présenté comme un éclairage, pas comme une liste d'auteurs ou de dates à apprendre.

Domaine	Contraintes ou ressources concrètes	Conséquence possible
Travail et emploi	Chômage, pénibilité, horaires, charge, stress, accidents du travail et maladies professionnelles	Expositions, fatigue et ressources matérielles influençant la santé et les possibilités de prévention.
Logement	Salubrité, stabilité, possibilité de dormir et de préparer des repas	Une urgence de logement peut passer avant une démarche de soins.
Éducation et formation	Scolarité, alphabétisation, compréhension des informations	Possibilités d'accéder à l'information, de la comprendre et de l'utiliser.
Services sanitaires et sociaux	Disponibilité, proximité, facilité d'accès	Une offre théorique peut rester difficilement utilisable.
Environnement quotidien	Eau potable, espaces verts, accès à une nourriture adaptée	Conditions favorables ou défavorables à des habitudes protectrices.

Les déterminants structuraux

À une échelle plus large se situent les politiques économiques et sociales, la protection sociale, la fiscalité, le marché du travail, la stigmatisation et les discriminations. Le contexte économique général, les crises et les expositions environnementales peuvent également agir sur toute une population. Ces facteurs influencent les conditions de vie et les ressources des services, avant même la rencontre entre un patient et un soignant.

La pollution de l'air, la contamination de l'eau ou une catastrophe illustrent des expositions que l'individu ne maîtrise pas seul. De la même façon, la disponibilité des équipes et des équipements de soins dépend en partie de décisions collectives. La prévention individuelle garde un intérêt, mais elle ne remplace pas l'action sur ces conditions.

06 Les déterminants commerciaux

Les **déterminants commerciaux** correspondent aux effets directs ou indirects sur la santé des activités privées poursuivant un objectif commercial. Le cours les rattache aux déterminants structuraux. Ils ne se limitent pas à un produit consommé : ils concernent aussi sa promotion, les conditions de production, les prix, les choix de recherche et l'influence sur les décisions publiques.

Voie d'influence	Exemple et mécanisme présenté
Production et environnement	Déforestation, pollutions liées à certaines activités ou conditions de production : la population peut subir des expositions indépendamment de sa volonté.
Promotion et normes de consommation	La publicité peut rendre certains produits plus visibles, désirables ou socialement valorisés.
Influence sur les règles	Le lobbying cherche à peser sur des décisions relatives à l'information, à la publicité, aux prix ou aux conditions de commercialisation.
Orientation des financements	La recherche et le développement peuvent être orientés vers les débouchés économiques attendus.
Transfert de responsabilité	Présenter la santé comme le seul résultat de choix personnels peut faire oublier le rôle de l'offre, des prix, de la publicité et des conditions de vie.

L'exemple du **Nutri-Score** illustre une tension entre information du consommateur, intérêt de la comparaison et limites de l'indicateur. Le cours invite à ne pas confondre un outil d'aide au choix avec une description exhaustive d'un aliment. Un indicateur peut être utile tout en restant perfectible ; son existence ne supprime pas les contraintes financières ou matérielles.

> **Raisonnement attendu**
>
> Au lieu de s'arrêter à « la personne a choisi ce produit », rechercher aussi comment l'offre, la promotion, le prix et l'environnement rendent ce choix plus ou moins probable. Cela n'efface pas toute capacité d'action personnelle : cela situe cette capacité dans un contexte.

07 Inégalités de santé et gradient social

Les **inégalités sociales de santé** sont des écarts d'état de santé entre groupes sociaux, produits par des logiques sociales et institutionnelles. Le cours les présente comme des différences socialement produites. Il ne suffit donc pas de constater une variation entre deux personnes : on cherche les mécanismes qui répartissent inégalement les expositions, les ressources et les possibilités de soins.

Le **gradient social** décrit une évolution de l'état de santé selon la position sociale. Il ne concerne pas seulement une opposition entre personnes très pauvres et très riches : des écarts peuvent apparaître tout au long de la distribution sociale. Le cours l'illustre par le diplôme, le revenu, certaines consommations, les limitations d'activité et différents problèmes de santé.

Lire le graphique d'espérance de vie sans confondre les indicateurs

Lecture du graphique présenté	Ce qu'il faut comprendre
Espérance de vie à 35 ans	Il s'agit du nombre moyen d'années restant à vivre à cet âge, et non de l'âge moyen au décès déjà atteint.
Hommes, données 2020–2022 : 40,5 contre 48,5 années restantes	Le graphique compare l'absence de diplôme à un diplôme supérieur au baccalauréat : écart de 8 ans dans cet exemple.
Femmes, données 2020–2022 : 47,2 contre 52,6 années restantes	La même comparaison donne un écart de 5,4 ans dans cet exemple.
Le niveau de diplôme est l'axe du graphique	Il ne faut pas remplacer cette variable par une autre catégorie sociale. Ces moyennes ne prédisent pas la durée de vie d'une personne donnée.

Le graphique international rapproche également PIB par habitant et espérance de vie à la naissance. Il montre une association à l'échelle des pays. Il ne démontre pas qu'une hausse donnée du PIB entraînerait automatiquement une hausse proportionnelle de la durée de vie, ni que la richesse serait la seule explication des écarts observés.

Une double difficulté

Des personnes plus exposées à des conditions défavorables peuvent aussi rencontrer davantage d'obstacles pour percevoir un besoin, accéder aux services et poursuivre les soins. Les inégalités d'exposition et les inégalités d'accès peuvent ainsi se cumuler.

08 Genre, discriminations et adéquation des soins

Les rapports sociaux de **genre** influencent les rôles attendus, les charges quotidiennes, les expositions et la manière dont une plainte est interprétée. Ils ne se confondent pas avec le sexe biologique. Le cours utilise aussi l'exemple des recherches et des prises en charge historiquement davantage centrées sur les hommes pour montrer que les inégalités peuvent être produites au sein même du système de santé.

Situation discutée en cours : une plainte banalisée

Une femme décrit une gêne thoracique qui est d'abord attribuée à l'angoisse. Le diagnostic est reconnu plus tard. Cet exemple sert à analyser l'influence des représentations, de la charge familiale et des conditions de recours. Il ne fournit pas une règle permettant de trier les plaintes selon le sexe.

Les discriminations et la stigmatisation peuvent agir de plusieurs façons : altérer la confiance, décourager une démarche, réduire la qualité de l'écoute ou rendre une offre moins adaptée. Une personne qui anticipe un jugement peut hésiter à consulter. Le problème ne doit pas être ramené uniquement à son manque de volonté ou de connaissances.

Exemple fourni	Enjeu de santé publique
Représentations des symptômes selon le genre	Prendre au sérieux les besoins et éviter qu'un stéréotype remplace l'analyse de la situation.
Formation insuffisante à certaines présentations dermatologiques sur peau noire	L'existence d'une consultation ne garantit pas à elle seule une réponse adaptée à toutes les personnes.
Prévention du VIH et représentations des publics concernés	Une représentation trop étroite des bénéficiaires peut faire obstacle à une offre adaptée aux risques réels.
Crainte d'être jugé ou de voir une information divulguée	La confiance et la compréhension du fonctionnement des services participent au recours.

Ces exemples illustrent l'**adéquation des soins** : répondre au besoin réel, avec des compétences et une organisation adaptées. Les dimensions sociales se combinent ; le genre, les ressources économiques, la situation de logement et les expériences de discrimination ne doivent pas être étudiés comme des cases entièrement indépendantes.

09 Besoin, accès, recours et poursuite des soins

Recevoir une personne dans un service ne permet pas de voir tous les obstacles rencontrés auparavant. Le parcours proposé dans le cours distingue la perception d'un besoin, le recours aux soins, puis leur utilisation et leur poursuite. À chaque étape interviennent à la fois des caractéristiques de la population et celles du système de santé.

Un parcours, trois étapes reliées

Percevoir le besoin

Comprendre la situation
Littératie et confiance

→

Recourir aux soins

Connaître les droits
Trouver et atteindre l'offre

→

Utiliser et poursuivre les soins

Recevoir une réponse adaptée
Pouvoir suivre le projet

Lecture simplifiée du schéma du cours : un obstacle peut survenir à chaque étape, sur le versant de la personne comme sur celui de l'offre de soins.

Étape	Obstacles ou ressources de la personne	Caractéristiques de l'offre
Besoin perçu	Comprendre une information, reconnaître un problème, avoir confiance dans les services.	Information compréhensible sur les possibilités de soins et transparence.

Étape	Obstacles ou ressources de la personne	Caractéristiques de l'offre
Recours	Connaître les services et ses droits ; pouvoir se déplacer et organiser la démarche.	Disponibilité des infrastructures, proximité, répartition de l'offre et professionnels qualifiés.
Utilisation et adhésion	Faire face au coût, au temps nécessaire et aux contraintes quotidiennes ; disposer d'un soutien.	Adéquation de la réponse, formation des professionnels et adaptation de l'organisation.

L'**accès aux soins** concerne les possibilités d'obtenir les services nécessaires ; le **recours** correspond à la démarche effective. Une possibilité d'accès ne garantit donc pas le recours, et une consultation réalisée ne garantit pas la poursuite du projet de soins. Une difficulté peut se déplacer d'une étape à l'autre.

> **Exemple de cumul**
>
> Une personne peut identifier un besoin, mais manquer de transport pour consulter ; après la consultation, elle peut encore rencontrer une difficulté financière ou de logement qui rend le traitement difficile à suivre. Résoudre le premier obstacle ne suffit pas à faire disparaître les suivants.

Le schéma de Levesque et ses collègues, présenté en complément, approfondit cette mise en relation entre capacités des personnes et propriétés de l'offre. Pour réviser, l'essentiel est de pouvoir situer un obstacle et proposer un levier cohérent, sans réduire l'accès à la seule présence d'un établissement.

10 La littératie en santé

La **littératie en santé** renvoie aux connaissances, compétences et possibilités nécessaires pour accéder aux informations utiles à la santé, les comprendre, les évaluer et les utiliser. Elle ne se limite ni à savoir lire, ni à posséder un diplôme, ni à mémoriser une consigne médicale.

Opération	Question concrète
Accéder / repérer	La personne sait-elle où trouver une information ou à quel service s'adresser ?
Comprendre	Peut-elle donner un sens à l'information ou à l'explication reçue ?
Évaluer	Peut-elle apprécier l'intérêt d'une information et mettre en relation différentes possibilités ?
Utiliser / appliquer	Peut-elle mobiliser l'information pour décider et agir dans sa situation réelle ?

Deux approches se complètent. L'approche **clinique** concerne notamment la compréhension d'un traitement et les échanges avec les professionnels. L'approche de **santé publique** élargit l'analyse à la prévention, à la promotion de la santé et aux possibilités de décision dans la vie quotidienne. L'environnement informationnel et les politiques de santé contribuent aussi à ces possibilités.

Le numérique peut devenir un obstacle

L'exemple du rendez-vous pris sur une application montre qu'une démarche évidente pour une personne peut être difficile pour une autre : équipement, maîtrise de l'outil et compréhension des étapes conditionnent l'accès effectif. La difficulté ne se résume pas à un manque d'intérêt pour sa santé.

L'enquête Health Literacy Survey France 2020–2021 présentée dans le cours rapporte des difficultés pour 44 % des adultes concernant l'accès, la compréhension, l'évaluation et l'utilisation d'informations utiles à leur santé. Ce repère décrit l'enquête citée ; il ne signifie pas que ces personnes seraient incapables de toute décision.

Application dans l'échange

Employer des mots accessibles, rendre les étapes d'une démarche explicites et vérifier ce que la personne a compris permettent de repérer où se situe la difficulté. Comprendre une information et pouvoir la mettre en pratique sont deux questions différentes.

11 Le non-recours : trois formes à distinguer

Le **non-recours** désigne une situation dans laquelle une personne ne bénéficie pas d'une offre publique, de droits ou de services auxquels elle pourrait prétendre. Il ne correspond pas uniquement au refus volontaire d'un soin et ne permet pas, à lui seul, de connaître les raisons de la situation.

Forme de non-recours	Mécanisme	Exemple de lecture
Non-connaissance	La personne ignore l'existence du droit, du dispositif ou de l'offre.	Elle ne sait pas qu'une aide ou un service pourrait la concerner.
Non-demande	L'offre est connue, mais la demande n'est pas faite ou n'aboutit pas à une démarche complète.	La complexité, les contraintes, la crainte d'un jugement ou les difficultés de langue peuvent décourager la démarche.
Non-réception	Une demande a été engagée, mais la personne ne reçoit pas effectivement la prestation ou le service.	Les délais, des difficultés de coordination ou un obstacle administratif entravent le bénéfice effectif.

L'aide médicale de l'État est mobilisée dans le cours comme exemple de décalage entre possibilité d'un droit et bénéfice effectif. L'intérêt du raisonnement est d'identifier où se situe l'obstacle. Ce chapitre distingue les mécanismes de non-recours ; il ne constitue pas un mode d'emploi administratif des conditions d'attribution.

Relier non-recours et accès aux soins

La non-connaissance peut empêcher de percevoir une possibilité de recours. Une personne peut ensuite rencontrer une difficulté à demander, puis une difficulté à recevoir ou à utiliser l'offre. Les obstacles peuvent se cumuler. Il faut donc éviter d'assimiler une démarche commencée à un droit effectivement obtenu ou à un soin réellement accessible.

Conséquence pour l'accompagnement

Repérer l'étape qui bloque, expliquer les possibilités dans un langage accessible et orienter vers les interlocuteurs adaptés est plus utile que de répéter une consigne générale. L'accompagnement se construit avec la personne et tient compte de ses priorités immédiates.

12 Intervenir : universel ne signifie pas uniforme

Une **intervention de santé publique** est un effort ou une politique visant à améliorer la santé mentale et/ou physique d'une population. Elle peut être portée par des services gouvernementaux ou des organisations non gouvernementales. Elle ne se limite pas à une campagne d'information : elle peut agir sur des personnes, des communautés ou des systèmes.

Niveau	Objet de l'action	Illustration
Individuel / familial	Accompagner une personne dans sa situation.	Expliquer une démarche, informer, conseiller, orienter.
Communautaire	Mobiliser un groupe, un territoire ou des ressources collectives.	Travailler avec une association ou intervenir dans un établissement scolaire.
Systémique	Modifier l'organisation, les règles ou les conditions générales.	Faire évoluer une offre ou soutenir une politique favorable à la santé.

L'**universalisme proportionné** associe deux exigences : une action destinée à tous et une intensité adaptée aux besoins. Il évite d'opposer une offre universelle à un soutien plus important pour les personnes rencontrant le plus d'obstacles. L'objectif est de réduire le gradient social, et pas seulement d'améliorer une moyenne.

Approche	Risque ou intérêt
Offre identique pour tous, sans adaptation	Les personnes ayant déjà le plus de ressources peuvent en tirer davantage de bénéfices. Une action peut alors laisser persister, voire creuser, des écarts.
Action limitée à un seul groupe	Elle répond à certains besoins, mais ne remplace pas nécessairement une offre accessible à l'ensemble de la population.
Offre pour tous, soutien gradué selon les besoins	La portée est universelle et les moyens sont proportionnés aux obstacles et aux besoins rencontrés.

Exemple de mise en œuvre

Une information peut être proposée à tous, avec un accompagnement supplémentaire lorsque la langue, la mobilité, le numérique ou la précarité compliquent son utilisation. Proportionner l'aide ne signifie pas attribuer une même catégorie de difficulté à toutes les personnes d'un groupe.

13 La roue des interventions et l'exemple HPV

La **Public Health Intervention Wheel** présentée dans le cours organise 17 fonctions en cinq grandes familles et les relie aux niveaux individuel/familial, communautaire et systémique. Les fonctions peuvent se combiner. L'intervenant précise qu'il ne s'agit pas d'apprendre toute la roue par cœur : il faut comprendre la variété des moyens d'agir et savoir les reconnaître dans une situation.

Famille d'actions	Fonctions représentées
Surveiller, investiguer et repérer	Surveillance ; investigation des maladies et menaces pour la santé ; aller-vers ; dépistage ; repérage des cas.
Orienter et accompagner	Orientation et suivi ; gestion de cas ; fonctions déléguées.
Informer, éduquer et conseiller	Éducation en santé ; conseil ; consultation, au sens d'apporter ou de solliciter une expertise.
Agir collectivement	Collaboration ; constitution de coalitions ; organisation ou mobilisation communautaire.
Agir sur les représentations et les décisions	Plaidoyer ; marketing social ; élaboration et application de politiques favorables à la santé.

Un exemple qui combine plusieurs fonctions : la vaccination HPV

Action décrite dans le cours	Fonction ou intention
Suivre la couverture vaccinale	Surveiller l'évolution d'un indicateur.
Étudier les écarts selon les territoires et les obstacles sociaux	Identifier les besoins et orienter l'action.
Informer sur les HPV, leurs risques et l'intérêt de la vaccination	Éducation en santé et prévention.
Intervenir dans les établissements scolaires ou auprès de communautés	Aller-vers les publics au lieu d'attendre leur venue dans les services.
Travailler avec les structures hospitalières, municipales et les partenaires	Collaboration, orientation et organisation de l'offre.
Adapter une campagne aux jeunes et porter des arguments auprès des décideurs	Marketing social et plaidoyer.

L'**aller-vers** inverse la logique d'attente : les professionnels se rendent auprès des personnes ou des communautés. Le **marketing social**, dans ce contexte, vise une communication adaptée au public et à l'objectif de santé ; il ne se confond pas avec la promotion commerciale d'un produit. Le **plaidoyer** cherche à faire prendre en compte un enjeu de santé dans une décision.

14 Des stratégies publiques aux différentes couches

Le cours présente plusieurs domaines de stratégies nationales pour montrer comment une orientation générale peut se décliner en interventions. Les développements détaillés sont annoncés pour d'autres enseignements. Ici, l'objectif est de relier une action concrète aux déterminants sur lesquels elle cherche à agir.

Domaines cités	Lien avec les déterminants
Alimentation, nutrition et climat	Relier les possibilités de se nourrir, les pratiques, l'offre alimentaire et les effets environnementaux.
Santé mentale et psychiatrie	Prendre en compte les besoins de santé mentale, leurs déterminants et l'organisation des réponses.
Santé sexuelle ; vaccination et immunisation	Associer information, prévention, accès et organisation de l'offre.
Lutte contre le tabac ; lutte contre les cancers	Combiner des actions sur les expositions, l'information, la prévention et les conditions collectives.
Politique des 1 000 premiers jours ; promotion d'un sommeil de qualité	Considérer les moments de vie et les conditions qui favorisent la santé.

L'alimentation : un exemple d'action à plusieurs niveaux

Levier présenté	Niveau(x) principalement mobilisé(s)
Diversification des protéines, mobilité active et information	Mode de vie individuel, soutenu par des conditions collectives favorables.
Projets alimentaires territoriaux et ressources locales	Réseaux communautaires, organisation locale et possibilités de se procurer des aliments.
Qualité de l'offre, restauration collective, accessibilité physique et financière	Conditions de vie et environnement quotidien.
Éducation à une alimentation durable	Compréhension, capacités d'action et environnement éducatif.
Gouvernance, politiques environnementales et organisation des systèmes alimentaires	Conditions économiques, culturelles et environnementales générales.

Un classement peut être transversal

Un bilan de prévention à certains âges concerne des caractéristiques individuelles, mais son organisation relève aussi d'une politique. Les spécificités des territoires ultramarins ne sont pas un facteur biologique inné : elles renvoient notamment aux contextes culturels, sociaux et environnementaux. Une même action peut donc mobiliser plusieurs couches.

La précarité alimentaire illustre les liens entre budget, disponibilité de l'offre et possibilités de choix. Réduire l'intervention à une exhortation à « mieux manger » ne répond pas à une impossibilité matérielle. Le cours relie cette question à la santé de la population, à la durabilité de l'alimentation et à l'organisation collective.

15 Mobiliser le raisonnement infirmier

Le raisonnement infirmier relie le problème de santé aux conditions concrètes de vie. Il ne remplace pas l'évaluation clinique ; il l'élargit pour comprendre les besoins, les ressources et les obstacles. Le but est de proposer une aide utilisable, avec la personne et les interlocuteurs concernés.

Étape	Question utile
Décrire sans juger	Quel besoin ou quelle difficulté observe-t-on réellement ? Quelle est la demande de la personne ?
Situer les déterminants	Quelles habitudes, relations, conditions de vie ou règles collectives influencent la situation ?
Repérer l'étape d'accès qui bloque	La difficulté concerne-t-elle le besoin perçu, la démarche, l'accès matériel, la réponse reçue ou la poursuite des soins ?

Étape	Question utile
Identifier les ressources	Sur quels proches, services, professionnels, associations ou possibilités locales peut-on s'appuyer ?
Construire une réponse proportionnée	Quelle aide concrète répond à l'obstacle et aux priorités de la personne ?
Réévaluer	L'information a-t-elle été comprise ? La démarche est-elle devenue possible ? Un autre obstacle persiste-t-il ?

Situation d'application : un traitement difficile à suivre

Une personne vivant avec un diabète rencontre des difficultés à poursuivre son traitement et à organiser ses repas. Elle a des horaires contraints, un logement instable et peu de soutien. La conclusion « elle ne veut pas faire d'effort » ne décrit pas les obstacles. Le raisonnement consiste à explorer ces contraintes, la compréhension du projet et les possibilités d'accompagnement, plutôt qu'à multiplier des conseils impossibles à appliquer.

Cette lecture ne suppose pas que toutes les personnes en situation de précarité rencontrent les mêmes difficultés. Les déterminants orientent des questions et des possibilités d'action ; ils ne permettent ni d'étiqueter une personne, ni de déduire à l'avance son comportement. L'écoute reste nécessaire pour comprendre sa situation propre.

Fil conducteur

Observer le besoin → comprendre le contexte → repérer l'obstacle → mobiliser les ressources → adapter l'aide → vérifier ce qui devient effectivement possible.

16 Pièges QCM et confusions à éviter

Pour chaque proposition, préciser le niveau d'analyse, la population concernée et l'indicateur utilisé. Ces distinctions servent à comprendre et à justifier une réponse ; elles ne constituent pas des questions de partiel annoncées.

Confusion	Distinction à retenir
Déterminant = comportement individuel	Les déterminants comprennent aussi les dimensions sociales, économiques, institutionnelles et environnementales.
Modifiable = facile à changer	Une habitude peut être modifiable tout en étant fortement contrainte par l'environnement et les ressources.
Cinq couches = cinq causes indépendantes	Le modèle organise des niveaux d'influence imbriqués.
Gradient = seulement pauvres contre riches	Des écarts peuvent exister tout au long des positions sociales.

Confusion	Distinction à retenir
Un groupe présente une moyenne = chaque personne a cette caractéristique	Une association collective ne permet pas une prédiction individuelle certaine.
Espérance de vie à 35 ans = âge au décès	Cet indicateur mesure des années restant à vivre à partir de 35 ans.
Le même gradient vaut pour toutes les expositions	Le sens et l'ampleur peuvent varier selon l'exposition et l'indicateur.
Accès = recours = poursuite des soins	Possibilité, démarche effective et utilisation durable sont trois dimensions à distinguer.
Littératie = savoir lire	Il faut aussi pouvoir accéder à l'information, la comprendre, l'évaluer et l'utiliser.
Non-recours = refus volontaire	Non-connaissance, non-demande et non-réception correspondent à des mécanismes différents.
Offre identique = équité	Une aide peut devoir être plus importante lorsque les besoins ou les obstacles le sont davantage.
Universalisme proportionné = action réservée aux plus défavorisés	L'offre s'adresse à tous ; son intensité est adaptée aux besoins.
Intervention de santé publique = information uniquement	L'action peut concerner l'accompagnement, les communautés, l'organisation ou les politiques.
Marketing social = publicité commerciale	Ici, il s'agit d'adapter une communication à un public et à un objectif de santé.
Un chiffre d'enquête est valable sans contexte	Toujours associer valeur, indicateur, population et période.

17 Synthèse générale — L'essentiel du cours

La santé résulte d'influences imbriquées. Pour comprendre une situation, partir du besoin observé, puis élargir le regard aux expositions, aux ressources et aux conditions collectives qui rendent l'action possible ou difficile.

Repère de révision	Idée centrale
Déterminants	Ils dépassent les seuls facteurs de risque individuels et permettent une lecture en amont.
Cinq couches	Âge/sexe/constitution ; modes de vie ; réseaux ; conditions de vie et de travail ; contexte socio-économique, culturel et environnemental.

Repère de révision	Idée centrale
Déterminants commerciaux	Production, promotion, prix, recherche et influence sur les règles peuvent agir sur la santé.
Inégalités et gradient	Les ressources, les expositions et les possibilités de soins sont inégalement réparties.
Genre et discriminations	Les représentations et l'organisation peuvent produire des écarts dans la reconnaissance des besoins et les réponses.
Accès aux soins	Besoin perçu, recours et poursuite du projet s'analysent du côté des personnes et du système.
Littératie	Accéder, comprendre, évaluer et utiliser une information utile à la santé.
Non-recours	Distinguer non-connaissance, non-demande et non-réception.
Interventions	Agir aux niveaux individuel/familial, communautaire et systémique.
Universalisme proportionné	Une action pour tous, avec une intensité adaptée aux besoins.
Roue des interventions	Plusieurs fonctions se combinent : surveillance, accompagnement, éducation, mobilisation et action sur les décisions.
Posture infirmière	Décrire sans juger, explorer les contraintes, mobiliser les ressources et vérifier l'utilité réelle de l'aide.

La phrase à reconstruire

Une personne n'agit pas dans le vide : ses caractéristiques, son entourage, ses conditions de vie et le contexte collectif influencent sa santé et ses possibilités de soins. Une intervention pertinente relie ces niveaux au lieu de les opposer.

18 Définitions et mots-clés

Les définitions suivantes permettent de distinguer les concepts utilisés dans la fiche. Les sigles sont développés et les termes proches sont explicitement différenciés.

Terme	Définition
Déterminant de santé	Facteur personnel, social, économique ou environnemental qui influence l'état de santé d'une personne ou d'une population.
Facteur de risque	Facteur associé à une probabilité accrue de survenue d'un problème de santé dans une population donnée.
Facteur protecteur	Ressource ou condition qui contribue à préserver la santé ou à diminuer la probabilité d'un problème.

Terme	Définition
Incidence	Survenue de nouveaux cas d'un problème de santé dans une population au cours d'une période donnée.
Prévalence	Proportion de personnes présentant un état ou un problème de santé dans une population et à une période définies.
Mortalité	Décès observés dans une population au cours d'une période ; à distinguer de la survenue des nouveaux cas et de la fréquence des personnes atteintes.
Morbidité	Importance des problèmes de santé et de leurs conséquences dans une population, indépendamment du seul décès.
Mortalité évitable	Décès sur lesquels des actions de prévention ou de prise en charge peuvent contribuer à agir ; le cours l'illustre notamment par le tabac et l'alcool.
Modèle de Dahlgren et Whitehead	Modèle de 1991 organisant les déterminants en cinq couches imbriquées, des caractéristiques individuelles aux conditions générales de vie.
Champs du rapport de Lalonde	Cadre présenté dans le cours autour de la biologie humaine, de l'environnement, des habitudes de vie et de l'organisation des soins.
Mode de vie	Ensemble d'habitudes et de comportements quotidiens liés notamment à l'alimentation, au sommeil, à l'activité et aux consommations.
Sédentarité	Temps et comportements peu dépensiers, notamment en position assise ou allongée hors sommeil ; ne se résume pas à l'absence d'une séance de sport.
Nutrition	Processus par lesquels l'organisme utilise les aliments ; le cours relie apports, fonctionnement basal et dépenses liées à l'activité.
Capital social	Ressources relationnelles disponibles à travers la famille, les amis, les voisins, les groupes et les réseaux d'entraide.
Réseaux sociaux et communautaires	Liens et groupes de proximité pouvant apporter un soutien, transmettre des normes et influencer les possibilités d'action.
Soutien social	Aide et ressources apportées par l'entourage, pouvant intervenir dans la compréhension, l'organisation ou la poursuite d'une démarche.
Autonomie	Possibilité de prendre part aux décisions et d'être acteur de sa situation ; l'exemple de l'autodétermination l'associe au sentiment de compétence et d'appartenance.
Sentiment de compétence	Sentiment d'être capable de comprendre ou de réaliser une action, évoqué comme une ressource pour agir.
Appartenance sociale	Sentiment d'être inclus dans un groupe et de disposer de liens avec d'autres personnes.
Conditions de vie	Conditions matérielles et sociales du quotidien : logement, alimentation, éducation, services et environnement accessible.

Terme	Définition
Conditions de travail	Caractéristiques de l'activité professionnelle : horaires, pénibilité, charge, expositions et organisation.
AT / MP	Accident du travail / maladie professionnelle : catégories citées parmi les conséquences possibles des conditions de travail.
Déterminants structuraux	Conditions générales et règles collectives qui influencent la répartition des ressources, les conditions de vie et les expositions.
Déterminants commerciaux	Effets sur la santé des activités commerciales, notamment par la production, la promotion, les prix, la recherche et l'influence sur les décisions.
Lobbying	Action visant à influencer les décisions et les règles dans l'intérêt d'acteurs ou de secteurs ; le cours en analyse les conséquences possibles pour la santé publique.
Discrimination	Traitement défavorable reposant sur une caractéristique ou une appartenance attribuée, susceptible de produire des obstacles et des inégalités.
Stigmatisation	Dévalorisation d'une personne ou d'un groupe à partir d'une caractéristique, pouvant affecter la confiance et le recours aux services.
Sexe biologique	Caractéristique biologique située au centre du modèle des déterminants ; à distinguer des rapports sociaux de genre.
Genre	Dimension sociale des rôles, normes et rapports entre personnes, pouvant influencer expositions, ressources et réponses de soins.
Inégalités sociales de santé	Écarts d'état de santé entre groupes sociaux résultant de logiques sociales et institutionnelles.
Gradient social de santé	Variation de l'état de santé selon les positions sociales, au-delà d'une simple opposition entre les plus pauvres et les plus riches.
Position socio-économique	Situation d'une personne ou d'un groupe appréciée à travers des dimensions telles que diplôme, emploi ou ressources économiques.
Égalité	Principe d'un traitement ou d'une offre identique ; une offre identique ne garantit pas que chacun puisse en bénéficier autant.
Équité	Prise en compte des différences de besoins et d'obstacles pour permettre des possibilités de santé et de soins plus justes.
Espérance de vie à la naissance	Nombre moyen d'années de vie correspondant aux conditions de mortalité considérées pour une population ; ce n'est pas une prédiction individuelle.
Espérance de vie à 35 ans	Nombre moyen d'années restant à vivre à partir de 35 ans dans les conditions de mortalité considérées.
PIB	Produit intérieur brut, indicateur de l'activité économique ; le cours compare le PIB par habitant et l'espérance de vie à l'échelle des pays.

Terme	Définition
Besoin de santé perçu	Problème ou nécessité de santé reconnu par la personne ; sa perception dépend notamment de l'information et de la confiance.
Accès aux soins	Possibilités d'obtenir une réponse de soins adaptée, compte tenu des caractéristiques de la personne et de l'offre.
Recours aux soins	Démarche effective vers une offre de soins ; à distinguer de sa seule disponibilité théorique.
Adhésion / adhérence aux soins	Participation et possibilité de poursuivre le projet de soins dans la durée, influencées par la compréhension et les conditions de vie.
Adéquation des soins	Correspondance entre les besoins réels et la réponse proposée, avec des compétences et une organisation adaptées.
Littératie en santé	Connaissances et compétences permettant d'accéder à l'information, de la comprendre, de l'évaluer et de l'utiliser pour la santé.
Dimension numérique de la littératie	Possibilité d'utiliser les outils et informations numériques nécessaires à une démarche de santé, comme la recherche d'un rendez-vous.
Non-recours	Situation dans laquelle une personne ne bénéficie pas d'une offre, d'un droit ou d'un service auquel elle pourrait prétendre.
Non-connaissance	Forme de non-recours liée à l'ignorance de l'existence d'une offre ou d'un droit.
Non-demande	Forme de non-recours dans laquelle une offre connue ne fait pas l'objet d'une demande effective ou complète.
Non-réception	Forme de non-recours dans laquelle une démarche engagée ne conduit pas au bénéfice effectif du droit ou du service.
Précarité	Instabilité ou insuffisance de ressources et de conditions de vie pouvant limiter les possibilités d'action et rendre d'autres besoins immédiatement prioritaires.
Précarité alimentaire	Difficulté à accéder à une alimentation suffisante et adaptée, notamment en raison de contraintes économiques ou matérielles.
AME	Aide médicale de l'État : dispositif mobilisé dans le cours comme exemple de non-recours à un droit. Les mécanismes de non-recours sont distincts des règles d'attribution.
Intervention de santé publique	Effort ou politique visant à améliorer la santé mentale et/ou physique d'une population, à différents niveaux d'action.
Niveau communautaire	Échelle d'un groupe ou d'un territoire à laquelle des ressources et des actions collectives peuvent être mobilisées.
Niveau systémique	Échelle des organisations, des règles et des politiques qui influencent les conditions générales de santé.

Terme	Définition
Universalisme proportionné	Principe d'une intervention destinée à tous, avec une intensité adaptée aux besoins et aux obstacles rencontrés.
Aller-vers / outreach	Démarche par laquelle les professionnels se rendent auprès des personnes ou communautés, plutôt que d'attendre leur venue dans les services.
Surveillance en santé publique	Suivi d'informations et d'indicateurs pour décrire une situation de santé et son évolution, afin d'orienter l'action.
Dépistage	Démarche de recherche d'un problème de santé dans un public, distincte de la seule réponse à une plainte exprimée.
Orientation et suivi	Mise en relation avec des ressources ou professionnels adaptés et attention portée à la suite effective de la démarche.
Gestion de cas	Organisation et coordination d'un accompagnement tenant compte des besoins d'une personne et des différents intervenants.
Éducation en santé	Action favorisant la compréhension et les possibilités d'agir pour la santé.
Consultation, dans la roue des interventions	Apport ou sollicitation d'une expertise ; le terme ne désigne pas ici uniquement un rendez-vous de soins.
Collaboration	Travail conjoint entre acteurs pour répondre à un besoin de santé et coordonner leurs ressources.
Coalition	Regroupement d'acteurs autour d'un objectif commun, notamment pour mobiliser des moyens ou soutenir une action collective.
Plaidoyer / advocacy	Action visant à faire prendre en compte un enjeu de santé dans les décisions et les politiques.
Marketing social	Adaptation d'une communication à un public et à un objectif de santé ; à distinguer de la promotion commerciale.
HPV	Papillomavirus humains : exemple utilisé dans le cours pour articuler surveillance, information, aller-vers, orientation et plaidoyer autour de la vaccination.
Couverture vaccinale	Part d'une population ayant reçu la vaccination considérée, dans un périmètre et selon un critère définis.
SNS	Stratégie nationale de santé : cadre général auquel le cours rattache différents domaines de politiques de santé.
SNANC	Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat : exemple du cours reliant alimentation, conditions sociales et environnement.
Projet alimentaire territorial	Démarche locale citée pour rapprocher les acteurs et les ressources alimentaires et faciliter des évolutions adaptées à un territoire.